

Punto ENARM -- Preguntas Cirugia

234 tarjetas de @PuntoENARM (feb-sep 2026). Enunciado = dato clave que pregunta el ENARM. [[Nota]] = patología existente en el vault.

Feb 2026 (44)

- **N354** (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE PRIMERA ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE ACALASIA? ESOFAGOGRAMA BARITADO (IMAGEN EN PICO DE PÁJARO, COLA DE RATÓN)
- **N356** (Wed Feb 18): ¿EN QUÉ PACIENTES DEBE REALIZARSE DE FORMA OBLIGATORIA LA MANOMETRÍA ESOFÁGICA? EN TODOS LOS PACIENTES QUE SERÁN SOMETIDOS A CIRUGÍA
- **N357** (Wed Feb 18): ¿POR QUÉ SE DEBE REALIZAR UN ESOFAGOGRAMA ANUAL EN PACIENTES CON ACALASIA? POR EL RIESGO DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE
- **N359** (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL COMPLICACIÓN DE LA ACALASIA? MEGAESÓFAGO
- **N360** (Wed Feb 18): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL DE ELECCIÓN PARA LA ACALASIA? MIOTOMÍA DE HELLER MÁS FUNDUPLICATURA PARCIAL
- **N362** (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE PRIMERA ELECCIÓN PARA ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO? SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL (IMAGEN EN SACACORCHOS)
- **N365** (Thu Feb 19): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN PARA ERGE? FUNDUPLICATURA DE NISSEN
- **N367** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL ESÓFAGO DE BARRET? HISTOLÓGICO
- **N368** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE ELECCIÓN EN ESÓFAGO DE BARRET? RESECCIÓN MUCOSA Y ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA
- **N369** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DIVERTÍCULO DE ZENKER? ESOFAGOGRAMA BARITADO C5-C6
- **N370** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA HERNIA HIATAL? CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON TÉCNICA ANTIRREFLUJO TIPO NISSEN MÁS COLOCACIÓN DE MALLA EN DEFECTOS MAYORES DE 5 MM -- [[Hernias]]
- **N371** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DE OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO? BRIDAS POSTERIORES A EVENTO QUIRÚRGICO
- **N372** (Fri Feb 20): EN PACIENTES SIN ANTECEDENTE DE CIRUGÍA PREVIA, ¿CUÁL ES LA ETIOLOGÍA DE OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO? HERNIAS -- [[Hernias]]
- **N373** (Fri Feb 20): EN OBSTRUCCIÓN DISTAL DE INTESTINO DELGADO, ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DEL VÓMITO? FECALOIDE
- **N374** (Fri Feb 20): EN OBSTRUCCIÓN PROXIMAL DE INTESTINO DELGADO, ¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA DEL VÓMITO? GASTROALIMENTARIO
- **N375** (Fri Feb 20): ¿CUÁL ES EL ESTUDIO INICIAL EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL? RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN AP EN BIPEDESTACIÓN
- **N376** (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL GOLD STANDARD PARA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL? TAC
- **N377** (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO INICIAL EN OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO QUE RESUELVE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS? Sonda NASOGÁSTRICA -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N378** (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO GRUESO? CÁNCER COLORRECTAL
- **N379** (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL LUGAR DE PERFORACIÓN MÁS FRECUENTE EN OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO GRUESO? CIEGO

- **N380** (Mon Feb 23): ¿CUÁL ES EL VÓLVULO QUE CORRESPONDE AL 75% DE LOS CASOS? VÓLVULO DE SIGMOIDES
- **N381** (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL HALLAZGO RADIOGRÁFICO MÁS SENSIBLE EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? IMAGEN EN GRANO DE CAFÉ
- **N382** (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL HALLAZGO RADIOGRÁFICO MÁS FRECUENTE EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? AUSENCIA DE GAS RECTAL
- **N383** (Tue Feb 24): ¿CUÁL ES EL SIGNO EN ENEMA DE BARIO EN VÓLVULO DE SIGMOIDES? SIGNO DEL AS DE ESPADAS
- **N384** (Tue Feb 24): ¿QUÉ ES EL VÓLVULO DE CIEGO? TORSIÓN DEL CIEGO SOBRE EL EJE MESENTÉRICO
- **N385** (Tue Feb 24): FRACTURAS NO DESPLAZADAS DE HUMERO PROXIMAL (GRADOS I Y II DE NEER) SE TRATAN DE MANERA CONSERVADORA -- [[Fracturas]]
- **N386** (Tue Feb 24): FRACTURAS DE HUMERO PROXIMAL CON DOS FRAGMENTOS O FRACTURA-LUXACION REQUIEREN REDUCCION ABIERTA Y FIJACION INTERNA -- [[patologias/Fracturas]]
- **N387** (Tue Feb 24): LAS FRACTURAS DE LA DIAFISIS HUMERAL SON UNA URGENCIA Y SE EVALUAN CON EL ALGORITMO ATLS -- [[Fracturas]]
- **N390** (Tue Feb 24): EL ANTIBIOTICO EN FRACTURAS EXPUESTAS DEBE INICIARSE EN LAS PRIMERAS 3 HORAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCION -- [[Fracturas]]
- **N391** (Wed Feb 25): EN FRACTURAS DE RADIO Y CUBITO SE DEBE VALORAR NERVIO RADIAL, MEDIANO Y ULNAR -- [[Fracturas]]
- **N392** (Wed Feb 25): LA FRACTURA EN TENEDOR CORRESPONDE A FRACTURA DE COLLES -- [[Fracturas]]
- **N395** (Thu Feb 26): LA FRACTURA CONMINUTA INTRAARTICULAR DE LA BASE DEL PRIMER METACARPIANO SE CONOCE COMO FRACTURA DE ROLANDO -- [[Fracturas]]
- **N396** (Thu Feb 26): LA FRACTURA DEL CUELLO DEL QUINTO METACARPIANO SE CONOCE COMO FRACTURA DEL BOXEADOR -- [[patologias/Fracturas]]
- **N397** (Thu Feb 26): LA FRACTURA DE LA DIAFISIS CUBITAL PROXIMAL ASOCIADA A LUXACION DE LA CABEZA DEL RADIO ES LESION DE MONTEGGIA -- [[Fracturas]]
- **N398** (Thu Feb 26): LA FRACTURA DE LA DIAFISIS RADIAL DISTAL ASOCIADA A LUXACION DE LA CABEZA DEL CUBITO ES LESION DE GALEAZZI -- [[Fracturas]]
- **N400** (Thu Feb 26): LOS MUSCULOS AFECTADOS EN EL SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR SON SUPRAESPINOZO, INFRAESPINOZO, REDONDO MENOR Y SUBESCAPULAR
- **N401** (Thu Feb 26): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SINDROME DE HOMBRO DOLOROSO ES MANEJO FISIOTERAPEUTICO
- **N402** (Thu Feb 26): EN SINDROME DEL MANGUITO ROTADOR SE PUEDE UTILIZAR INFILTRACION INTRAARTICULAR CON CORTICOESTEROIDE MAS LIDOCAINA
- **N406** (Thu Feb 26): EL CODO DE NIÑERA ES UNA SUBLUXACION DE LA CABEZA DEL RADIO FUERA DEL LIGAMENTO ANULAR -- [[patologias/Tiron Del Codo Codo De Ninera]]
- **N407** (Thu Feb 26): EL MECANISMO DEL CODO DE NIÑERA ES TRACCION AXIAL DEL MIEMBRO SUPERIOR -- [[Tiron Del Codo Codo De Ninera]]
- **N408** (Thu Feb 26): EL TRATAMIENTO DEL CODO DE NIÑERA ES SUPINACION FORZADA DEL ANTEBRAZO EN EXTENSION MAS FLEXION POSTERIOR -- [[Tiron Del Codo Codo De Ninera]]
- **N410** (Thu Feb 26): EN EL ESGUINCE CERVICAL GRADO I HAY DOLOR CERVICAL Y ESPASMO MUSCULAR SIN SIGNOS FISICOS -- [[Esguince Cervical]]
- **N412** (Fri Feb 27): EN EL ESGUINCE CERVICAL GRADO III EXISTEN SIGNOS Y SINTOMAS NEUROLOGICOS -- [[Esguince Cervical]]
- **N415** (Fri Feb 27): DESPUES DE 48 HORAS EN ESGUINCE CERVICAL SE INDICA CALOR SUPERFICIAL, REPOSO RELATIVO E HIGIENE POSTURAL -- [[Esguince Cervical]]

Mar 2026 (40)

- **N416** (Mon Mar 02): LA FRACTURA DE CADERA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE INGRESO DE ANCIANOS A ORTOPEdia -- [[patologias/Fracturas]]
- **N417** (Mon Mar 02): LA PRINCIPAL COMPLICACION Y CAUSA DE MORTALIDAD EN FRACTURA DE CADERA ES EL TROMBOEMBOLISMO VENOSO -- [[Fracturas]]
- **N418** (Mon Mar 02): LA COMPLICACION MAS FRECUENTE EN ANCIANOS POSTOPERADOS DE FRACTURA DE CADERA ES EL DELIRIUM -- [[Delirium]]
- **N420** (Mon Mar 02): LAS FRACTURAS INTRACAPSULARES DE CADERA PUEDEN LESIONAR LOS VASOS RETICULARES Y COMPROMETER LA VASCULARIZACION DE LA CABEZA FEMORAL -- [[Fracturas]]
- **N421** (Tue Mar 03): EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DESPLAZADAS DE CADERA EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA ES ARTROPLASTIA -- [[Fracturas]]
- **N422** (Tue Mar 03): LA LUXACION DE CADERA MAS FRECUENTE ES LA POSTERIOR (90%)
- **N426** (Tue Mar 03): EL TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE DIAFISIS FEMORAL ES CLAVO INTRAMEDULAR EN LAS PRIMERAS 24 HORAS -- [[patologias/Fracturas]]
- **N427** (Tue Mar 03): LA PRINCIPAL COMPLICACION DE FRACTURA DE TIBIA ES LA AUSENCIA DE CONSOLIDACION -- [[Fracturas]]
- **N428** (Tue Mar 03): EL LIGAMENTO MAS LESIONADO EN ESGUINCE DE TOBILLO ES EL PERONEO ASTRAGALINO ANTERIOR -- [[Esguince De Tobillo]]
- **N430** (Tue Mar 03): EL GOLD ESTANDAR EN ARTRITIS SEPTICA ES EL CULTIVO DE LIQUIDO SINOVIAl
- **N432** (Wed Mar 04): LA VIA MAS FRECUENTE DE INFECCION EN ARTRITIS SEPTICA ES HEMATOGENA
- **N435** (Wed Mar 04): LA ETIOLOGIA MAS FRECUENTE DE OSTEOMIELITIS ES STAPHYLOCOCCUS AUREUS (80-90%)
- **N436** (Thu Mar 05): LOS PILARES DEL TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS SON DRENAJE QUIRURGICO, INMOVILIZACION Y ANTIBIOTICO INTRAVENOSO
- **N437** (Thu Mar 05): LA NECROSIS AVASCULAR DE LA CABEZA FEMORAL ES MAS FRECUENTE EN NIÑOS DE 4-8 AÑOS Y ES UNILATERAL EN 90% -- [[Enfermedad De Legg Calve Perthes]]
- **N438** (Thu Mar 05): EL GOLD ESTANDAR DIAGNOSTICO EN NECROSIS AVASCULAR DE CABEZA FEMORAL ES RESONANCIA MAGNETICA
- **N440** (Thu Mar 05): EL TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCION EN LUMBALGIA AGUDA ES PARACETAMOL -- [[Lumbalgia]]
- **N442** (Thu Mar 05): EL HUESO DEL CARPO QUE MAS SE FRACTURA ES EL ESCAFOIDES -- [[Fracturas]]
- **N445** (Thu Mar 05): EL TUMOR OSEO BENIGNO MAS FRECUENTE ES EL OSTECONDROMA
- **N446** (Fri Mar 06): EL TUMOR OSEO MAS FRECUENTE EN MAYORES DE 50 AÑOS SON LAS METASTASIS OSEAS -- [[patologias/Tumores Oseos Malignos]]
- **N447** (Fri Mar 06): LA MAYORIA DE LAS FRACTURAS DE CLAVICULA OCURREN EN EL TERCIO MEDIO -- [[Fracturas]]
- **N448** (Fri Mar 06): LA PRINCIPAL CAUSA DE LESION TRAUMATICA EN NIÑOS ES LA FRACTURA SUPRACONDILEA DE HUMERO -- [[Lesiones Epifisarias Y Fracturas Especiales En El Paciente Pediatrico]]
- **N450** (Fri Mar 06): EN FRACTURAS DE DIAFISIS HUMERAL EL NERVIO QUE MAS FRECUENTEMENTE SE LESIONA ES EL NERVIO RADIAL -- [[Fracturas]]
- **N451** (Mon Mar 09): EN FRACTURA LUXACION DE MONTEGGIA PUEDE LESIONARSE EL NERVIO INTEROSEO POSTERIOR (RAMA DEL NERVIO RADIAL) -- [[Fracturas]]
- **N452** (Mon Mar 09): EN FRACTURA DISTAL DE RADIO EL NERVIO QUE PUEDE LESIONARSE ES EL NERVIO MEDIANO -- [[Fracturas]]

- **N455** (Mon Mar 09): LA EPICONDILITIS SE CONOCE COMO CODO DE TENISTA
- **N456** (Tue Mar 10): LA EPITROCLEITIS SE CONOCE COMO CODO DE GOLFISTA
- **N457** (Tue Mar 10): LA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN ES LA INFLAMACION DE LA VAINA DE LOS TENDONES ABDUCTOR LARGO Y EXTENSOR CORTO DEL PULGAR
- **N458** (Tue Mar 10): LA BURSITIS PRERROTULIANA SE CONOCE COMO RODILLA DE BEATA
- **N460** (Tue Mar 10): EL DOLOR DE LA BURSITIS ANSERINA AUMENTA AL SUBIR Y BAJAR ESCALERAS
- **N508** (Wed Mar 18): LA APENDICITIS AGUDA INICIA CON DOLOR PERIUMBILICAL QUE MIGRA A FOSA ILIACA DERECHA -- [[Apendicitis (Pedia■trica)]]
- **N509** (Wed Mar 18): EL SIGNO DE MCBURNEY ES DOLOR EN FOSA ILIACA DERECHA A LA PALPACION -- [[Apendicitis (Pedia■trica)]]
- **N510** (Wed Mar 18): EL ESTUDIO DE ELECCION EN ADULTOS PARA APENDICITIS ES TAC ABDOMINAL
- **N511** (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE APENDICITIS ES APENDICECTOMIA
- **N512** (Thu Mar 19): LA COLECISTITIS AGUDA SE ASOCIA A OBSTRUCCION DEL CONDUCTO CISTICO POR LITIASIS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N513** (Thu Mar 19): EL SIGNO DE MURPHY POSITIVO ES CARACTERISTICO DE COLECISTITIS AGUDA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N514** (Thu Mar 19): EL ESTUDIO DE ELECCION EN COLECISTITIS ES ULTRASONIDO ABDOMINAL -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N515** (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE COLECISTITIS ES COLECISTECTOMIA
- **N517** (Thu Mar 19): LA CAUSA MAS FRECUENTE DE PANCREATITIS AGUDA ES LITIASIS BILIAR -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N518** (Thu Mar 19): EL MANEJO INICIAL DE PANCREATITIS ES AYUNO, HIDRATACION IV Y ANALGESIA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N524** (Thu Mar 19): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE VARICES ESOFAGICAS ES LIGADURA ENDOSCOPICA

Apr 2026 (2)

- **N677** (Mon Apr 20): LA MITAD DE LOS LIQUIDOS EN QUEMADURAS SE ADMINISTRA EN LAS PRIMERAS 8 HORAS -- [[Quemaduras]]
- **N680** (Mon Apr 20): LAS QUEMADURAS DE TERCER GRADO REQUIEREN MANEJO QUIRURGICO

May 2026 (3)

- **N778** (Fri May 15): LA LITIASIS RENAL MAS FRECUENTE ES DE OXALATO DE CALCIO -- [[Litiasis Urinaria]]
- **N780** (Fri May 15): EL ESTUDIO DE ELECCION PARA LITIASIS RENAL ES TAC HELICOIDAL SIN CONTRASTE -- [[Litiasis Urinaria]]
- **N806** (Tue May 26): EL FACTOR DE RIESGO MAS IMPORTANTE PARA CANCER DE MAMA ES SEXO FEMENINO -- [[patologias/Ca■ncer Mamario]]

Jun 2026 (17)

- **N844** (Wed Jun 03): LA ENDOSCOPIA EN MALLORY-WEISS SE RECOMIENDA ENTRE LAS 6 Y 24 HORAS POSTERIORES AL EVENTO
- **N855** (Fri Jun 05): LA LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE DE LA ÚLCERA GÁSTRICA ES LA CURVATURA MENOR
- **N859** (Mon Jun 08): LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EN LA ÚLCERA PÉPTICA COMPLICADA ES EL SANGRADO
- **N862** (Mon Jun 08): EL SIGNO RADIOLÓGICO CLÁSICO DE UNA ÚLCERA PERFORADA ES AIRE SUBDIAFRAGMÁTICO
- **N863** (Mon Jun 08): EL ESTUDIO INICIAL EN ÚLCERA PERFORADA ES LA RADIOGRAFÍA TORACOABDOMINAL
- **N864** (Mon Jun 08): LA ENFERMEDAD DE MENÉTRIER SE DEBE A SOBREEXPRESIÓN DE TGF-ALFA CON HIPERPLASIA FOVEOLAR
- **N865** (Mon Jun 08): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA ENFERMEDAD DE MENÉTRIER ES ENDOSCOPIA CON BIOPSIA
- **N866** (Tue Jun 09): EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE MENÉTRIER ES CETUXIMAB; EN CASOS REFRACTARIOS SE REALIZA GASTRECTOMÍA TOTAL
- **N867** (Tue Jun 09): EL 90% DE LOS GASTRINOMAS SE LOCALIZAN EN EL TRIÁNGULO DE PASSARO
- **N872** (Wed Jun 10): LA TRIADA CLÁSICA DE LA ACALASIA ES DISFAGIA, REGURGITACIÓN Y PÉRDIDA DE PESO
- **N874** (Wed Jun 10): EL SIGNO RADIOLÓGICO CARACTERÍSTICO DE ACALASIA ES EL ESÓFAGO EN PICO DE PÁJARO
- **N875** (Wed Jun 10): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA ACALASIA ES LA MIOTOMÍA DE HELLER CON FUNDUPLICATURA
- **N877** (Wed Jun 10): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ERGE CRÓNICA
- **N882** (Fri Jun 12): LA TRÍADA CLÁSICA DE LA ACALASIA ES DISFAGIA, REGURGITACIÓN Y PÉRDIDA DE PESO
- **N884** (Fri Jun 12): EL SIGNO RADIOLÓGICO CARACTERÍSTICO DE LA ACALASIA ES EL ESÓFAGO EN PICO DE PÁJARO
- **N885** (Fri Jun 12): EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA ACALASIA ES LA MIOTOMÍA DE HELLER CON FUNDUPLICATURA
- **N887** (Mon Jun 15): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA ESÓFAGO DE BARRETT ES LA ERGE CRÓNICA

Jul 2026 (74)

- **N941** (Thu Jul 02): LA COLELITIASIS ES EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA COLECISTITIS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N942** (Thu Jul 02): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLELITIASIS ES EL ULTRASONIDO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N943** (Thu Jul 02): LA PRINCIPAL MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE LA COLELITIASIS ES EL CÓLICO BILIAR -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N944** (Thu Jul 02): LOS PACIENTES CON COLELITIASIS ASINTOMÁTICA GENERALMENTE NO REQUIEREN TRATAMIENTO -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N945** (Thu Jul 02): LA COMPLICACIÓN MÁS GRAVE DE LA COLECISTECTOMÍA ES LA LESIÓN DE LA VÍA BILIAR -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N946** (Fri Jul 03): EL SIGNO DE MURPHY POSITIVO ES CARACTERÍSTICO DE COLECISTITIS AGUDA -- [[patologías/Trastornos De La Via Biliar]]

- **N947** (Fri Jul 03): EL ULTRASONIDO ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS AGUDA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N948** (Fri Jul 03): EL ENGROSAMIENTO DE LA PARED VESICULAR MAYOR DE 5 MM SUGIERE COLECISTITIS AGUDA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N949** (Fri Jul 03): LOS CRITERIOS DE TOKIO SE UTILIZAN PARA EL DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS AGUDA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N950** (Fri Jul 03): LA COLECISTECTOMÍA TEMPRANA ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN COLECISTITIS AGUDA LEVE -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N951** (Mon Jul 06): EL SÍNDROME DE MIRIZZI CONSISTE EN LA IMPACTACIÓN DE UN LITO EN EL INFUNDÍBULO DE LA VESÍCULA O CONDUCTO CÍSTICO -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N952** (Mon Jul 06): LA COLEDOCOLITIASIS ES LA PRESENCIA DE LITOS EN EL COLÉDOCO -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N953** (Mon Jul 06): EL ESTUDIO DE ELECCIÓN EN COLEDOCOLITIASIS CON DILATACIÓN DEL COLÉDOCO ES LA COLANGIORRESONANCIA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N954** (Mon Jul 06): LA CPRE ES EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA COLEDOCOLITIASIS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N955** (Mon Jul 06): LA TRÍADA DE CHARCOT ESTÁ FORMADA POR FIEBRE, ICTERICIA Y DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N956** (Tue Jul 07): LA PÉNTADA DE REYNOLDS ES LA TRÍADA DE CHARCOT MÁS CHOQUE Y ALTERACIÓN DEL ESTADO DE CONCIENCIA -- [[patologías/Trastornos De La Via Biliar]]
- **N957** (Tue Jul 07): ESCHERICHIA COLI ES EL MICROORGANISMO MÁS FRECUENTEMENTE AISLADO EN COLANGITIS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N958** (Tue Jul 07): EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DE LA COLANGITIS ES EL DRENAJE DE LA VÍA BILIAR MEDIANTE CPRE -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N959** (Tue Jul 07): EL ÁCIDO URSODESOXICÓLICO ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N960** (Tue Jul 07): LA TRÍADA DE RIGLER CONSISTE EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, AEROBILIA Y CÁLCULO BILIAR ECTÓPICO -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N961** (Wed Jul 08): LA PRINCIPAL CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN ADULTOS MAYORES SON LAS ENFERMEDADES BILIARES -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N962** (Wed Jul 08): LA CEFTRIAXONA ES EL ANTIBIÓTICO CON MAYOR RIESGO DE FORMACIÓN DE LITOS BILIARES -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N963** (Wed Jul 08): LOS CÁLCULOS BILIARES MÁS FRECUENTES SON LOS MIXTOS CON PREDOMINIO DE COLESTEROL -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N965** (Wed Jul 08): LOS PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA TIENEN MAYOR RIESGO DE COLELITIASIS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N967** (Thu Jul 09): LA COLECISTITIS ENFISEMATOSA SE ASOCIA A MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE GAS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N968** (Thu Jul 09): ANTE ICTERICIA O COLANGITIS EN UN PACIENTE COLECISTECTOMIZADO DEBE SOSPECHARSE COLEDOCOLITIASIS RESIDUAL -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N969** (Thu Jul 09): LA COLANGITIS SUPURATIVA AGUDA SE PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA EN PACIENTES MAYORES DE 70 AÑOS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N971** (Fri Jul 10): LA ARTERIA CÍSTICA ES LA PRINCIPAL FUENTE DE IRRIGACIÓN DE LA VESÍCULA BILIAR
- **N972** (Fri Jul 10): LOS FACTORES DE RIESGO CLÁSICOS PARA COLELITIASIS SON FEMALE, FORTY, FERTILITY Y FAT -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N973** (Fri Jul 10): EL DOLOR DEL CÓLICO BILIAR APARECE TÍPICAMENTE DE UNA A CINCO HORAS DESPUÉS DE LA INGESTA DE ALIMENTOS -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N974** (Fri Jul 10): EL DICLOFENACO INTRAMUSCULAR ES EL TRATAMIENTO INICIAL DEL CÓLICO BILIAR -- [[Trastornos De La Via Biliar]]

- **N975** (Fri Jul 10): LA VESÍCULA EN PORCELANA ES UNA INDICACIÓN DE COLECISTECTOMÍA PROFILÁCTICA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N976** (Mon Jul 13): LA COLELITIASIS ES LA ETIOLOGÍA DE APROXIMADAMENTE EL 90% DE LOS CASOS DE COLECISTITIS AGUDA -- [[patologías/Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N977** (Mon Jul 13): LA COLECISTITIS ALITIÁSICA PRESENTA MAYOR RIESGO DE PERFORACIÓN -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N978** (Mon Jul 13): LA GAMMAGRAFÍA BILIAR ES EL ESTUDIO MÁS ESPECÍFICO PARA COLECISTITIS AGUDA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N979** (Mon Jul 13): LA MASA PALPABLE EN HIPOCONDRIO DERECHO CORRESPONDE AL SIGNO DE COURVOISIER -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N980** (Mon Jul 13): EL DOLOR DE LA COLECISTITIS AGUDA SUELE IRRADIARSE A LA REGIÓN INFRAESCAPULAR DERECHA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N981** (Tue Jul 14): EL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE COLECISTITIS AGUDA REQUIERE CRITERIOS CLÍNICOS, DATOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA E IMAGEN COMPATIBLE -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N982** (Tue Jul 14): LA COLECISTECTOMÍA TEMPRANA SE RECOMIENDA DURANTE LOS PRIMEROS SIETE DÍAS DEL EPISODIO DE COLECISTITIS AGUDA LEVE -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N983** (Tue Jul 14): LA COLECISTITIS AGUDA GRADO III SE ASOCIA A DISFUNCIÓN ORGÁNICA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N984** (Tue Jul 14): EN LA COLECISTITIS AGUDA GRADO III DEBE ESTABILIZARSE AL PACIENTE ANTES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N985** (Tue Jul 14): LA COLECISTECTOMÍA TARDÍA SE RECOMIENDA DESPUÉS DE LA ESTABILIZACIÓN EN PACIENTES CON COLECISTITIS GRAVE -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N987** (Wed Jul 15): UN COLÉDOCO MENOR DE 6 MM SE CONSIDERA DE CALIBRE NORMAL -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N988** (Wed Jul 15): UN COLÉDOCO DE SEIS A OCHO MILÍMETROS ES INDICACIÓN DE COLANGIORRESONANCIA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N989** (Wed Jul 15): UN COLÉDOCO MAYOR DE OCHO MILÍMETROS ES INDICACIÓN DE CPRE -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N990** (Wed Jul 15): LA PANCREATITIS ES UNA DE LAS COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DE LA COLEDOLITIASIS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N991** (Thu Jul 16): LA ENTRADA MÁS FRECUENTE DE LA INFECCIÓN EN LA COLANGITIS ES LA VÍA PORTAL -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N992** (Thu Jul 16): BACTEROIDES FRAGILIS ES EL ANAEROBIO MÁS FRECUENTEMENTE AISLADO EN COLANGITIS -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N993** (Thu Jul 16): LA PÉNTADA DE REYNOLDS CORRESPONDE A COLANGITIS SUPURATIVA AGUDA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N994** (Thu Jul 16): LA ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA ES EL PRIMER PASO EN EL MANEJO DE LA COLANGITIS -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N995** (Thu Jul 16): EL DRENAJE DE LA VÍA BILIAR MEDIANTE CPRE ES EL TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LA COLANGITIS OBSTRUCTIVA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N998** (Fri Jul 17): EL ÍLEO BILIAR ES UNA OBSTRUCCIÓN MECÁNICA INTESTINAL PRODUCIDA POR UN CÁLCULO BILIAR IMPACTADO -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N999** (Fri Jul 17): EL ÍLEON TERMINAL ES EL SITIO MÁS FRECUENTE DE IMPACTACIÓN EN EL ÍLEO BILIAR -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N1000** (Fri Jul 17): EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN DEL ÍLEO BILIAR ES LA ENTEROLITOTOMÍA -- [[Trastornos De La Vía Biliar]]
- **N1021** (Fri Jul 24): LA MORTALIDAD GENERAL DE LA PANCREATITIS AGUDA ES DEL 5 AL 17% -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1025** (Fri Jul 24): LA MICROLITIASIS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE PANCREATITIS AGUDA RECURRENTE -- [[Pancreatitis Aguda]]

- **N1027** (Mon Jul 27): LA PANCREATITIS AGUDA LEVE NO PRESENTA COMPLICACIONES LOCALES NI SISTÉMICAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1028** (Mon Jul 27): LA PANCREATITIS AGUDA MODERADA PRESENTA COMPLICACIONES LOCALES O SISTÉMICAS SIN FALLA ORGÁNICA PERSISTENTE -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1029** (Mon Jul 27): LA PANCREATITIS AGUDA GRAVE SE CARACTERIZA POR FALLA ORGÁNICA PERSISTENTE DURANTE MÁS DE 48 HORAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1030** (Mon Jul 27): UNA PCR MAYOR DE 150 MG/DL ES UN CRITERIO DE MAL PRONÓSTICO EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1031** (Tue Jul 28): UN APACHE II MAYOR DE 7 ES UN CRITERIO DE GRAVEDAD EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1034** (Tue Jul 28): EL MOMENTO IDEAL PARA REALIZAR TOMOGRAFÍA CON CONTRASTE Y DETECTAR NECROSIS PANCREÁTICA ES ENTRE LAS 72 Y 96 HORAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1035** (Tue Jul 28): LOS ANTIBIÓTICOS NO DEBEN ADMINISTRARSE DE FORMA PROFILÁCTICA EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1037** (Wed Jul 29): LA VÍA ENTERAL ES LA VÍA DE ALIMENTACIÓN PREFERIDA EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1038** (Wed Jul 29): LAS COLECCIONES PANCREÁTICAS AGUDAS APARECEN ANTES DE LAS CUATRO SEMANAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1039** (Wed Jul 29): EL PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO ES UNA COLECCIÓN LÍQUIDA HOMOGÉNEA CON PARED BIEN DEFINIDA QUE APARECE DESPUÉS DE CUATRO SEMANAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1040** (Wed Jul 29): LA NECROSIS AMURALLADA ES UNA COLECCIÓN ENCAPSULADA MADURA DE NECROSIS PANCREÁTICA CON UNA PARED BIEN DEFINIDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1041** (Thu Jul 30): EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA REQUIERE AL MENOS DOS DE TRES CRITERIOS: DOLOR CARACTERÍSTICO, ELEVACIÓN DE ENZIMAS PANCREÁTICAS E IMAGEN COMPATIBLE -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1044** (Thu Jul 30): LA LIPASA ES MÁS ESPECÍFICA Y PERMANECE ELEVADA DURANTE MÁS TIEMPO QUE LA AMILASA EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1045** (Thu Jul 30): LAS DOS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE PANCREATITIS AGUDA SON LA LITIASIS BILIAR Y EL CONSUMO DE ALCOHOL -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1047** (Fri Jul 31): EL ULTRASONIDO DE HÍGADO Y VÍAS BILIARES DEBE REALIZARSE PARA BUSCAR ETIOLOGÍA BILIAR EN PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1048** (Fri Jul 31): LA TOMOGRAFÍA NO SE REQUIERE DE RUTINA CUANDO EL DIAGNÓSTICO DE PANCREATITIS AGUDA ES CLARO Y EL PACIENTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1049** (Fri Jul 31): LA RESONANCIA MAGNÉTICA Y LA COLANGIORRESONANCIA SON ÚTILES CUANDO SE SOSPECHA OBSTRUCCIÓN BILIAR Y EL ULTRASONIDO NO ES CONCLUYENTE -- [[Trastornos De La Via Biliar]]
- **N1050** (Fri Jul 31): LA CPRE URGENTE ESTÁ INDICADA EN PANCREATITIS BILIAR ACOMPAÑADA DE COLANGITIS -- [[Pancreatitis Aguda]]

Aug 2026 (54)

- **N1051** (Mon Aug 03): LA CPRE NO ESTÁ INDICADA DE RUTINA EN TODOS LOS PACIENTES CON PANCREATITIS AGUDA BILIAR -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1054** (Mon Aug 03): LA ANALGESIA ADECUADA FORMA PARTE DEL TRATAMIENTO INICIAL DE LA PANCREATITIS AGUDA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1055** (Mon Aug 03): LA ALIMENTACIÓN ORAL TEMPRANA PUEDE INICIARSE CUANDO EL PACIENTE LA TOLERA SIN NECESIDAD DE ESPERAR LA NORMALIZACIÓN DE LAS ENZIMAS PANCREÁTICAS -- [[Pancreatitis Aguda]]

- **N1057** (Wed Aug 05): LA NECROSIS PANCREÁTICA ESTÉRIL NO REQUIERE ANTIBIÓTICOS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1058** (Wed Aug 05): LA PRESENCIA DE GAS DENTRO DE UNA COLECCIÓN PANCREÁTICA SUGIERE NECROSIS INFECTADA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1059** (Wed Aug 05): EL TRATAMIENTO DE LA NECROSIS PANCREÁTICA INFECTADA SIGUE UN ABORDAJE ESCALONADO CON ANTIBIÓTICOS, DRENAJE Y NECROSECTOMÍA CUANDO ES NECESARIA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1060** (Wed Aug 05): LA COLECISTECTOMÍA DEBE REALIZARSE DURANTE EL MISMO INTERNAMIENTO EN LA PANCREATITIS BILIAR LEVE PARA DISMINUIR RECURRENCIAS -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1061** (Thu Aug 06): LA PANCREATITIS CRÓNICA ES UN PROCESO INFLAMATORIO PERSISTENTE E IRREVERSIBLE QUE PRODUCE CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y FUNCIONALES DEL PÁNCREAS
- **N1062** (Thu Aug 06): LA PRINCIPAL CAUSA DE PANCREATITIS CRÓNICA ES EL ALCOHOLISMO
- **N1064** (Thu Aug 06): SE REQUIERE APROXIMADAMENTE 90% DE PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN EXOCRINA PARA QUE APAREZCAN DATOS DE MALABSORCIÓN
- **N1065** (Thu Aug 06): EL DIAGNÓSTICO INICIAL DE PANCREATITIS CRÓNICA SE REALIZA CON ULTRASONIDO O TOMOGRAFÍA
- **N1067** (Fri Aug 07): EN LA PANCREATITIS CRÓNICA LAS CONCENTRACIONES DE AMILASA Y LIPASA PUEDEN SER NORMALES
- **N1068** (Fri Aug 07): EL TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS CRÓNICA AUTOINMUNE ES CON CORTICOESTEROIDES
- **N1069** (Fri Aug 07): CUALQUIER PROCESO QUE LESIONE EL PÁNCREAS PUEDE PRODUCIR TROMBOSIS DE LA VENA ESPLÉNICA -- [[Pancreatitis Aguda]]
- **N1070** (Fri Aug 07): EL ABDOMEN AGUDO NO TRAUMÁTICO ES UN SÍNDROME DE DOLOR ABDOMINAL DE INSTAURACIÓN RECIENTE QUE REQUIERE DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y PRECISO -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N1072** (Mon Aug 10): LA LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA PURA PERMITE CONFIRMAR O DESCARTAR UNA PATOLOGÍA SIN REALIZAR UNA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA ADICIONAL
- **N1073** (Mon Aug 10): LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PURA PERMITE TRATAR COMPLETAMENTE LA PATOLOGÍA IDENTIFICADA SIN CONVERSIÓN A CIRUGÍA ABIERTA
- **N1074** (Mon Aug 10): LA ESTABILIDAD HEMODINÁMICA ES UN REQUISITO PARA REALIZAR LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA EN ABDOMEN AGUDO -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N1075** (Mon Aug 10): LA PERITONITIS GENERALIZADA Y LA INESTABILIDAD HEMODINÁMICA SON CONTRAINDICACIONES PARA LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA -- [[Trauma Abdominal]]
- **N1076** (Tue Aug 11): UNA HERIDA LIMPIA ES AQUELLA EN LA QUE NO SE ABREN VÍSCERAS NI CAVIDADES QUE CONTIENEN FLORA BACTERIANA -- [[patologías/Infeccion De Herida Y Sitio Quirurgico]]
- **N1077** (Tue Aug 11): LA TASA DE INFECCIÓN DE UNA HERIDA LIMPIA ES MENOR DE 2% -- [[Infeccion De Herida Y Sitio Quirurgico]]
- **N1078** (Tue Aug 11): UNA HERIDA LIMPIA-CONTAMINADA ES AQUELLA EN LA QUE SE ACCEDE DE FORMA CONTROLADA A CAVIDADES O VÍSCERAS CON FLORA BACTERIANA -- [[Infeccion De Herida Y Sitio Quirurgico]]
- **N1079** (Tue Aug 11): LA TASA DE INFECCIÓN DE LAS HERIDAS LIMPIAS-CONTAMINADAS ES APROXIMADAMENTE DE 3 A 10% -- [[Infeccion De Herida Y Sitio Quirurgico]]
- **N1080** (Tue Aug 11): UNA HERIDA CONTAMINADA PRESENTA CONTAMINACIÓN SIGNIFICATIVA SIN QUE EXISTA UNA INFECCIÓN ESTABLECIDA -- [[Cuidado Y Cicatrizacion De Las Heridas]]
- **N1081** (Wed Aug 12): EL SÍNDROME DE LYNCH SE ASOCIA A MUTACIONES EN GENES REPARADORES DEL ADN Y AUMENTA EL RIESGO DE CÁNCER COLORRECTAL Y ENDOMETRIAL
- **N1082** (Wed Aug 12): EN EL SÍNDROME DE LYNCH SE RECOMIENDA COLONOSCOPIA CADA 1 A 2 AÑOS A PARTIR DE LOS 18 AÑOS

- **N1084** (Wed Aug 12): LA CATARATA ES UNA OPACIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL CRISTALINO O DE SU CÁPSULA QUE PRODUCE DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL -- [[Catarata]]
- **N1086** (Thu Aug 13): EL ENVEJECIMIENTO ES EL PRINCIPAL FACTOR ASOCIADO A CATARATA Y LA DIABETES ES SU PRINCIPAL CAUSA METABÓLICA -- [[patologias/Catarata]]
- **N1087** (Thu Aug 13): EL ESTÁNDAR DE ORO PARA EL DIAGNÓSTICO DE CATARATA ES LA EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA COMPLETA CON MIDRIÁTICO -- [[Catarata]]
- **N1088** (Thu Aug 13): EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA CATARATA SE REALIZA MEDIANTE FACOEMULSIFICACIÓN -- [[Catarata]]
- **N1089** (Thu Aug 13): LA ENDOFTALMITIS ES LA COMPLICACIÓN MÁS GRAVE DE LA CIRUGÍA DE CATARATA -- [[Endoftalmitis]]
- **N1098** (Wed Aug 19): LA ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA POR TROMBOSIS VENOSA PUEDE PRESENTARSE CON DOLOR ABDOMINAL SORDO, DIARREA Y EVACUACIONES CON SANGRE
- **N1099** (Wed Aug 19): LA ANGIOGRAFÍA ES EL ESTÁNDAR DE ORO SEÑALADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
- **N1100** (Wed Aug 19): LA COLITIS ISQUÉMICA AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA EL COLON IZQUIERDO, PARTICULARMENTE EL ÁNGULO ESPLÉNICO O PUNTO DE GRIFFITH
- **N1101** (Thu Aug 20): LA ADENITIS MESENTÉRICA ES LA SEGUNDA CAUSA DE DOLOR EN FOSA ILÍACA DERECHA -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N1107** (Fri Aug 21): LA PRINCIPAL CAUSA DE RETENCIÓN URINARIA EN EL HOMBRE ES LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA -- [[Hiperplasia Prostatica Benigna]]
- **N1110** (Fri Aug 21): EL VARICOCELE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE INFERTILIDAD MASCULINA EN EL MUNDO
- **N1116** (Fri Aug 21): LA PRINCIPAL CAUSA DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO ES LA INSUFICIENCIA DEL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR -- [[Reflujo Gastroesofágico en Pediatría]]
- **N1118** (Fri Aug 21): LA FUNDUPLICATION DE NISSEN ES EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN PARA LA ERGE
- **N1119** (Fri Aug 21): LA HERNIA INGUINAL INDIRECTA ES EL TIPO DE HERNIA INGUINAL MÁS FRECUENTE -- [[Hernias]]
- **N1120** (Fri Aug 21): LA HERNIA INGUINAL INDIRECTA SE LOCALIZA LATERAL A LOS VASOS EPIGÁSTRICOS Y SALE A TRAVÉS DEL ANILLO INGUINAL INTERNO -- [[patologias/Hernias]]
- **N1121** (Wed Aug 26): LA HERNIA INGUINAL DIRECTA PROTRUYE A TRAVÉS DEL TRIÁNGULO DE HESSELBACH Y SE LOCALIZA MEDIAL A LOS VASOS EPIGÁSTRICOS -- [[Hernias]]
- **N1122** (Wed Aug 26): LA HERNIA DE LITTRÉ ES AQUELLA QUE CONTIENE UN DIVERTÍCULO DE MECKEL -- [[Hernias]]
- **N1123** (Wed Aug 26): LA HERNIA DE RICHTER CONTIENE UNA PORCIÓN DE LA PARED ANTIMESENTÉRICA DEL INTESTINO DELGADO -- [[Hernias]]
- **N1124** (Wed Aug 26): ANTES DE UNA ESPLENECTOMÍA SON OBLIGATORIAS LAS VACUNAS CONTRA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, NEUMOCOCO Y MENINGOCOCO -- [[Vacunas del Esquema Nacional - Descripción Individual]]
- **N1125** (Wed Aug 26): EL TRACOMA ES UNA QUERATOCONJUNTIVITIS CAUSADA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS -- [[Tracoma]]
- **N1128** (Thu Aug 27): EL SIGMOIDES ES EL SEGMENTO DEL COLON AFECTADO CON MAYOR FRECUENCIA POR DIVERTICULOSIS -- [[Enfermedad Diverticular Del Colon]]
- **N1129** (Thu Aug 27): LA TOMOGRAFÍA ES EL ESTUDIO DE ELECCIÓN EN LA DIVERTICULITIS -- [[Enfermedad Diverticular Del Colon]]
- **N1130** (Thu Aug 27): LA DIVERTICULITIS ESTADIO IA DE HINCHEY CORRESPONDE A INFLAMACIÓN PERICÓLICA Y FLEMÓN -- [[patologias/Enfermedad Diverticular Del Colon]]
- **N1134** (Fri Aug 28): LA SOSPECHA DE FRACTURA DE BASE DE CRÁNEO CONTRAINDICA LA COLOCACIÓN DE Sonda NASOGÁSTRICA Y SE PREFERE LA VÍA OROGÁSTRICA -- [[Traumatismo Craneoencefálico]]

- **N1136** (Mon Aug 31): LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA PRODUCE SÍNTOMAS DE VACIAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y POSTMICCIONALES -- [[Hiperplasia Prostatica Benigna]]
- **N1138** (Mon Aug 31): UN PUNTAJE IPSS MENOR DE 8 CORRESPONDE A SINTOMATOLOGÍA LEVE DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA -- [[Hiperplasia Prostatica Benigna]]
- **N1139** (Mon Aug 31): UN PUNTAJE IPSS DE 8 A 19 CORRESPONDE A SINTOMATOLOGÍA MODERADA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA -- [[Hiperplasia Prostatica Benigna]]
- **N1140** (Mon Aug 31): UN PUNTAJE IPSS DE 20 A 35 CORRESPONDE A SINTOMATOLOGÍA SEVERA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA -- [[patologias/Hiperplasia Prostatica Benigna]]